

全科慢性胃炎患者调理方案优化

戴宇超

无锡市新吴区梅村街道社区卫生服务中心，江苏 无锡 214112

摘要：慢性胃炎在全科门诊中就诊率持续上升，呈现症状迁延与反复发作的典型特征。面对传统调理方案的连续性差、依从性低等问题，本文聚焦于优化全科场景下的慢性胃炎调理路径，提出基于风险分层、模块化干预、个体化随访与信息化支持的多维方案。通过构建整合式管理模型，调动多专业协作资源，推动从“症状应对”向“慢病管理”转变，提升调理质量与患者参与度，形成可推广、可复制的基层实践路径。

关键词：慢性胃炎；全科医学；调理方案；风险分层；整合管理

0 引言

慢性胃炎是一种常见的消化系统疾病，主要特征为胃黏膜的持续性炎症。这种疾病通常是由多个因素的共同作用所致，如幽门螺杆菌感染、免疫系统紊乱、药物对胃黏膜的刺激，以及长期不健康的饮食习惯。这些因素的相互影响会导致患者胃黏膜受损，逐渐丧失自我修复能力，从而形成慢性胃炎。长期病程与反复发作，使慢性胃炎在全科门诊中呈现管理难度高、依从性差的典型特征。面对患者个体差异与调理需求碎片化之间的矛盾，现行干预模式已显疲态。全科医疗具备首诊、分层与连续随访的天然优势，亟需在此基础上探索更具整合性、可操作性与人本导向的调理路径。

1 全科视角下慢性胃炎患者调理的现状分析

1.1 慢性胃炎流行病学特点与就诊趋势

全科门诊面对的慢性胃炎患者以症状迁延、复发相对频繁为共同图景。基于内镜的多中心资料提示，在内镜就诊人群中慢性胃炎检出率居高位，提示基层首诊环节承压；我国幽门螺杆菌（*Helicobacter pylori*, Hp）感染仍较常见，近期系统综述与 Meta 分析估计总体感染率约四成，随年龄上升而增加。与此同时，2023 年全国基层医疗卫生机构诊疗人次显著增长，慢病与常见病的管理重心持续下沉。慢性萎缩性胃炎与胃癌发生风险相关，这一事实要求在全科场景前移风险识别与分层随访，形成“首诊评估—规范转诊—连续管理”的就诊路径。

1.2 目前全科调理模式的结构与不足

现实中的全科调理多围绕“四环联动”：Hp 检测与根除、抑酸与黏膜保护、生活方式干预、健康教育随访。结构并不缺位，问题出在执行的连续性与精准度。常见短板包括：基于风险的分层管理不足，症状主导替代理化与内镜证据，转诊阈值差异较大；除菌方案更多依赖经验，地区耐药谱与既往用药史的纳入不够充分，导致疗效波动；信息化随访薄弱，饮食、心理与用药计划难以长期落地。指南与共识已明确“检测—治疗”与规范化管理要点，仍需在基层把原则转化为可操作路径，例如在首诊内置风险评估清单、药学支持介入方案选择、设定随访节点与反馈闭环，以减少碎片化干预与“短疗程、快中断”的隐性失效。

1.3 患者行为特征与调理障碍因素

全科人群中，慢性胃炎患者的就医行为呈现三种稳定特征：症状驱动的自我用药偏好、对长期规则疗程的耐受度有限、对侵入性检查存在顾虑。健康素养与依从性之间的紧密关联在近年研究中被反复证实，低素养患者更易在除菌过程中因不良反应担忧或经济与时间成本而中断，亦常见家庭共餐、共用餐具等习惯带来的再感染风险。改善路径不在于简单叠加宣教材料，而在于将处方从“复杂多药”转为“清单化、

阶段化”，并以家庭为单位开展卫生行为干预，配合分期随访与不良反应管理提示，提升自我管理能力与完成率，从而把一次性干预转化为可持续的日常习惯。

2 基于全科医疗优势的调理方案优化路径

2.1 调理方案优化的核心原则

优化目标应紧扣“全科—慢病—连续”三条主线。以患者为中心，围绕症状控制、黏膜修复与复发预防三个层面设定阶段性目标，形成可验证、可迁移的管理框架。风险分层是基础：依据年龄、报警症状、既往内镜结果、幽门螺杆菌状态、非甾体抗炎药使用史，划定随访强度与转诊阈值。循证与可负担并行：药物选择遵循指南证据，同时结合地区耐药谱与患者承受能力，避免“强方案短周期”的盲目叠加。全程管理贯穿始终：在首诊即明确干预起止点与随访节律，记录患者报告结局与不良反应，保留复盘空间。双向协同成为保障：与消化专科建立清晰的上转—回转机制，避免信息割裂；整合营养、药学与心理资源，提升非药物干预的含金量。文化与家庭情境需要被看见：饮食结构、作息模式与家庭卫生习惯直指再感染与复发风险，在地化策略往往比抽象宣教更有效。

2.2 个体化调理路径设计

首诊配置三项“必问—必测—必判”：一问报警征象与药物史；一测 HP 状态（首选¹³C 尿素呼气试验）及血常规、粪便隐血按需补充；一判风险等级与转诊阈值，高龄合并消瘦、吞咽困难或黑便者直接专科评估。此举压实安全底线，为个体化调理赢得时间与边界。

建立五类模块并在电子病历内置决策提示：①酸相关不适，以质子泵抑制剂或钾离子竞争性酸阻滞剂短程控制，必要时合用黏膜保护；②HP 阳性，采用含铋四联方案并记录既往抗生素暴露，疗程完成后 4 周复测；③动力障碍主导，优先生活方式与节律化少量多餐，短期使用促动力药，设定停药点以防依赖；④萎缩或肠化提示的黏膜易损，强化营养评估与专科随访频率；⑤NSAIDs 相关风险，完成胃黏膜风险再评估并与用药科室协同减量或替代。各模块可叠加使用，但须在处方笺标注“主目标—次目标”，避免目标游移。

饮食方面不再罗列禁忌词，而是制作“7 日样板餐单+可替换清单”，覆盖常见场景（工作日外卖、家庭聚餐、夜宵），并给出触发原则——辛辣、油炸、浓茶咖啡与烈酒若引发症状，即按“减半—替代—暂停”的顺序处理；作息部分强调晚餐—就寝间隔 ≥ 3 小时与每周 ≥ 150 分钟中等强度运动；心理与压力管理纳入“微处方”，如每晚 10 分钟腹式呼吸与每周一次放松训练，护士在首月内进行 2 次电话核对。中医干预采用“证候—膳食—外治”组合，明确目标为缓解症状与改善睡眠，不与西药作用目标产生冲突。

随访设定“2—8—24 周”三个里程碑节点：2 周看耐受与早期应答，8 周评估症状缓解与依从性，24 周关注复发与生活质量。每次复诊都进行用药精简评估，满足目标后优先减量抑酸药，再审查保护剂，最终保留生活方式与心理干预这一“长期骨架”。家庭成员 HP 筛查与餐具消毒习惯同步推进，可显著降低再感染与交叉感染风险。

2.3 整合式健康管理模型

以“医—护—药—营—心—检—社”七个角色构建小型协作网：全科医师统筹评估与转诊；护士充当病例管理员；药师负责用药核对与不良反应处置建议；营养师落地餐单；心理师开展简短干预；检验与内镜科对接复测；社区工作者组织家庭与群体教育。流程分三段：首诊 30 分钟完成评估与路径拟定；首月强化随访，采用“第 7 天+第 21 天”电话核查与一次门诊复评；进入维持期后按 3—6 个月节律回访。为了减少患者奔波，尽量在同一次门诊内完成营养与药学联合咨询。

建立三张“表”：①风险与症状双维评估表，标准化分层；②干预处方表，包含药物、饮食、运动、心理与中医外治项，并注明起止点；③随访与预警表，列出“何时需要加急回诊”的触发条件（黑便、进行性消瘦、持续夜间痛）。同时设置两项“约束”：处方前先完成用药核对，随访前必须读取患者最近一周

患者报告结局对基层机构而言，先在一个社区卫生服务中心试点，形成 SOP 与操作清单，再向周边机构辐射，减少落地阻力。为提升患者黏性，可引入“家庭单位”管理与小组化健康教育，以同伴效应稳住生活方式改变曲线。

2.4 信息化技术辅助调理管理

数字化不应堆砌功能，而要服务路径。门诊端在电子病历内嵌“调理路径插件”，自动抓取报警征象、HP 检测结果与用药史，生成分层建议与转诊提示；患者端使用轻量级小程序或 App 记录每日症状、进食与睡眠，采用 0—10 分量表回传患者报告结局，并设置用药提醒与不良反应快速反馈入口；管理端以看板展示人群分层、疗程完成率与再感染可疑个案，便于团队快速校正。规则引擎承担告警任务，例如连续三天症状评分上升 ≥ 3 分即推送护士回访；长期未打卡则触发“简讯+电话”双重提醒。数据使用遵循最小必要原则，重要节点（HP 复测、转诊、处方调整）留痕可追溯，满足隐私与合规要求。信息化把碎片信息收束为可执行信号，使全科场景的连续性与可视化管理相互支撑。

3 结语

本文从全科医学视角出发，系统分析当前慢性胃炎调理的困境与机制，提出兼顾循证、实际与可行性的调理优化策略。通过构建以患者为中心的多维干预模型，强化风险分层与动态管理，调动多方资源协同，推动调理路径标准化、智能化、连续化。未来可进一步结合区域实践验证模型适配性，并深化智能技术在慢性病管理中的融合应用，助力基层慢病管理体系持续进化。

参考文献

- [1]常增伟, 冯彦飞. 中西医结合调治慢性胃炎效果好[J]. 家庭生活指南, 2025, 41(1): 87-88.
- [2]丁红燕. 如何调理慢性胃炎[J]. 幸福家庭, 2020(7): 71.
- [3]秦春艳. 慢性胃炎重在调理[J]. 家庭医药. 快乐养生, 2023(11): 29.